脳神経内科医が答える からだの不思議 #14

しびれが出たら
何科を受診すればいい？

— 脳神経内科・整形外科・内科の使い分け —

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

こんな経験ありませんか？

「手がしびれてきた。どこの病院に行けばいいんだろう…？」

「足のしびれが続くけど、整形外科でいいのかな？」

「整形外科で異常なしと言われたのに、しびれが治らない」

原因によって受診すべき科がまったく異なります

しびれの神経解剖 — 中枢性 vs 末梢性

中枢性しびれ

場所：脳・脊髄が原因

代表例

脳梗塞・脳出血
多発性硬化症・脊髄炎

パターン

体の片側全体
（顔＋腕＋足）
体幹レベル以下

末梢性しびれ

場所：末梢神経・脊椎が原因

代表例

頸椎症・手根管症候群
糖尿病性神経障害
ビタミンB12欠乏

パターン

特定の指だけ
足の裏だけ
両足がじわじわ

「場所のパターン」が受診科の選択に直結する最大の手がかり

どの科に行けばいい？ — 科別の対象疾患

診療科	主な対象疾患	しびれのパターン例
脳神経内科	脳梗塞・多発性硬化症 ギランバレー症候群 糖尿病性神経障害・脊髄炎	片側の顔+腕+足 体幹レベル以下 両足先のじわじわ感
整形外科	頸椎症・椎間板ヘルニア 手根管症候群 脊柱管狭窄症	首の動きで変化する腕のしびれ 親指〜中指3本 腰痛＋片足のしびれ
内科 （糖尿病・代謝）	糖尿病性末梢神経障害 ビタミンB12欠乏 甲状腺機能低下症	両足先から対称性に上がる 足先の灼熱感 慢性・緩徐進行

「整形外科で異常なし」でも安心しないで — 内科的・神経内科的な原因が隠れることがある

受診科の選び方フローチャート

!

Q1　突然起きた（数分〜数時間）しびれ？
　　顔・腕・足が片側 / ろれつ / 視野異常を伴う

→ **すぐ救急へ。脳卒中の可能性**

骨

Q2　首や腰を動かすと悪化する？
　　腕や足の特定の指だけしびれる？ 首・腰の痛みを伴う

→ **整形外科　頸椎・腰椎・手根管症候群を疑う**

内

Q3　糖尿病・大量飲酒・偏食がある？
　　両足先からじわじわ上がってくる？

→ **内科（糖尿病内科）　代謝・栄養性の末梢神経障害**

脳

Q4　上記に当てはまらない？
　　体の片側だけ・特定レベル以下・再発を繰り返す？

→ **脳神経内科　脳・脊髄・複合的な末梢神経疾患を精査**

救急へ — 脳卒中のFASTサイン

F Face	A Arm	S Speech	T Time
顔のゆがみ	**腕の脱力**	**言語障害**	**発症時刻の確認**
笑ったとき片側の口角が下がる	両腕を前に出すと片側が下がる	ろれつが回らない・言葉が出ない	治療の時間窓（4.5時間以内）がある

しびれだけの脳梗塞（感覚性脳卒中）も存在します

突然起きたしびれは、FASTがなくても救急を受診してください

末梢性しびれの代表例

手根管症候群　整形外科

パターン

親指〜薬指（手のひら側）
夜間・早朝に悪化

ポイント：妊娠・甲状腺低下・透析があれば内科も

糖尿病性神経障害　内科・神経内科

パターン

両足先から対称性に
灼熱感・しびれが上がる

ポイント：血糖コントロール改善が治療の柱

頸椎椎間板ヘルニア　整形外科

パターン

首の動きで悪化
腕の特定の指だけしびれる

ポイント：難治例・脊髄症は脳神経外科も

多発性硬化症　脳神経内科

パターン

数週間で部位が変わる
体幹レベル以下がすべてしびれる

ポイント：若い女性に多い・再発を繰り返す

こんなときは脳神経内科への受診を急いで

1. 片側の顔・腕・足がすべてしびれる（同時に起きる）
2. 数週間で体の別の場所に広がった（多発性硬化症など）
3. 体の胸・腰の高さより下の全体がしびれる（脊髄病変）
4. 足がしびれると同時に力が入りにくい・歩きにくい
5. 排尿・排便のコントロールが急に悪くなった（緊急サイン）
6. 糖尿病がないのに両足がじわじわとしびれて悪化する

Take Home Message

1. しびれの原因は「中枢性（脳・脊髄）」と「末梢性（末梢神経・骨格系）」に大別される

2. 「場所のパターン」が受診科の最大の手がかり
片側の顔+腕+足 → 脳神経内科　首の動きで変化 → 整形外科　両足じわじわ → 内科

3. 突然起きた片側のしびれはFASTを確認し、迷わず救急へ
「しびれだけの脳梗塞」も存在する

4. 「整形外科で異常なし」でも原因が見つかっていなければ
脳神経内科への相談を恐れないで